04. DAS KREISLAUFSYSTEM – UPDATE

DAUER : 03:59 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video bietet eine tiefgreifende Aktualisierung des traditionellen Modells des Kreislaufsystems, indem es zeigt, dass es tatsächlich drei verschiedene Venensysteme gibt. Sie werden die komplexen Wechselwirkungen zwischen Blut und Herz sowie die verschiedenen Wege, die das Blut nehmen kann, kennenlernen, was die intrinsische Intelligenz des Kreislaufs veranschaulicht. Die Theorien von Pionieren wie M. Herveillat und M. Batson ermöglichen es, die Rolle der Venen neu zu überdenken und die Kardinal-, Vitellin- und Nabelvenensysteme im Detail zu verstehen. Praktische Implikationen für häufige Pathologien wie Rückenschmerzen und lokale Azidosen werden ebenfalls behandelt, um Ihnen konkrete Werkzeuge zur Bereicherung Ihrer osteopathischen Praxis an die Hand zu geben.

DAS KREISLAUFSYSTEM: EIN UPDATE

DIE ENTWICKLUNG DER GEFÄßBAHNEN

Das traditionelle Bild des **Kreislaufsystems** ist das eines Kreislaufs, der vom Herzen über die **Arterien** wegführt und über die **Venen** zum Herzen zurückkehrt. Obwohl dies zutrifft, gibt es tatsächlich drei verschiedene venöse Systeme:

- **Ein Wirbelsäulensystem:** ausschließlich in Verbindung mit dem Wirbelsäulensystem.
- **Ein Pfortadersystem:** das das gesamte **ektodermale**, **mesodermale** und **endodermale** System drainiert.
- **Ein drittes venöses System.**

Das Blut kehrt tatsächlich zum Herzen zurück, kann aber auch umkehren oder andere Wege einschlagen, abhängig von den Drücken und Unterdrücken im Herzen. Wenn beispielsweise das Pfortadersystem überlastet ist und seinen Rückfluss nicht gewährleisten kann, nimmt das Blut einen anderen Weg. Es nutzt ein **Hohlvenen-Rückflusssystem** über diaphragmatische Austauschzonen.

Das bedeutet, dass sich die Drücke anpassen können. Das Blut folgt keinem einfachen geschlossenen Kreislauf, sondern kann verschiedene Wege einschlagen. Es gibt eine **intrinsische Intelligenz** in diesem System, die immer darauf abzielt, zum Herzen

zurückzukehren.

EINE ERNEUERTE SICHT AUF DAS VENENSYSTEM

Das Blut fließt vom Herzen weg und kehrt dorthin zurück. Unsere Vorstellung vom Venensystem und damit vom Kreislaufsystem stammt jedoch aus dem 17. Jahrhundert. Diese Auffassung wird nun **erneuert**.

Die Pioniere dieses neuen Verständnisses sind **M. Herveillat** und **M. Batson**. Es stellt sich die Frage: "Aber mir wurde immer gesagt, dass die Venen Klappen haben, um den Rückfluss des Blutes zu verhindern." Tatsächlich sind diese Klappen nur in den **großen Venen** vorhanden, und nicht im gesamten Netzwerk. Es gibt nur sehr wenige kleine Klappen dieser Art.

DIE VERSCHIEDENEN ZU UNTERSUCHENDEN VENENSYSTEME

Wir werden untersuchen:

- **Die Kardinalvenen:** die zu Subkardinal- und Supra-Kardinalvenen werden.
- **Das Dottersacksystem:** in Bezug zur Leber.
- **Das Nabelsystem:** das im vertebral-kaval-portal-System neu kartiert und in die osteopathische Praxis integriert wird.

Das Kardinalsystem wird sich so stark verändern, dass wir im Detail sehen werden, wie es Gewebe und Strukturen bildet, die sich sowohl in die **ektodermalen** als auch in die **mesodermalen** Strukturen integrieren.

Eine Methode wurde entwickelt, um dies in die Praxis umzusetzen. Es ist entscheidend, deren Bedeutung verstanden zu haben.

PRAKTISCHE UND KLINISCHE IMPLIKATIONEN

Stasen und Veränderungen des **Abdominaldrucks** können erhebliche Folgen haben. Zum Beispiel können **Lumbago** die Folge einer Überlastung des Pfortadersystems sein.

Es ist dann notwendig, das Wirbelsäulensystem durch diese portale Überlastung zu "entlasten". Hier setzt der gesamte Mechanismus der **Diskopathien** an.

Jede Form von Stase führt zu einer **Azidität**, selbst lokal, die gelöst werden muss. Es wird immer dasselbe Schema verwendet. Zum Beispiel geht ein **Sakrumtumor** fast immer mit **Metastasen** in der linken Niere, der linken Lunge und dem Gehirn einher. Man beobachtet eine Konstante in der Trajektorie.

Bei **Prostataproblemen** kann man dasselbe Schema finden. Darüber hinaus besteht eine **vaskuläre Kontinuität** zwischen den Wirbelsäulensinus und den Sakralsinus des kleinen Beckens.

Eine Blutentnahme aus einem Arm spiegelt nicht die Gesamtheit des Blutes wider, das aus einem venösen, arteriellen oder anderen System entnommen werden könnte.



ABB. — Herz-Kreislauf-System

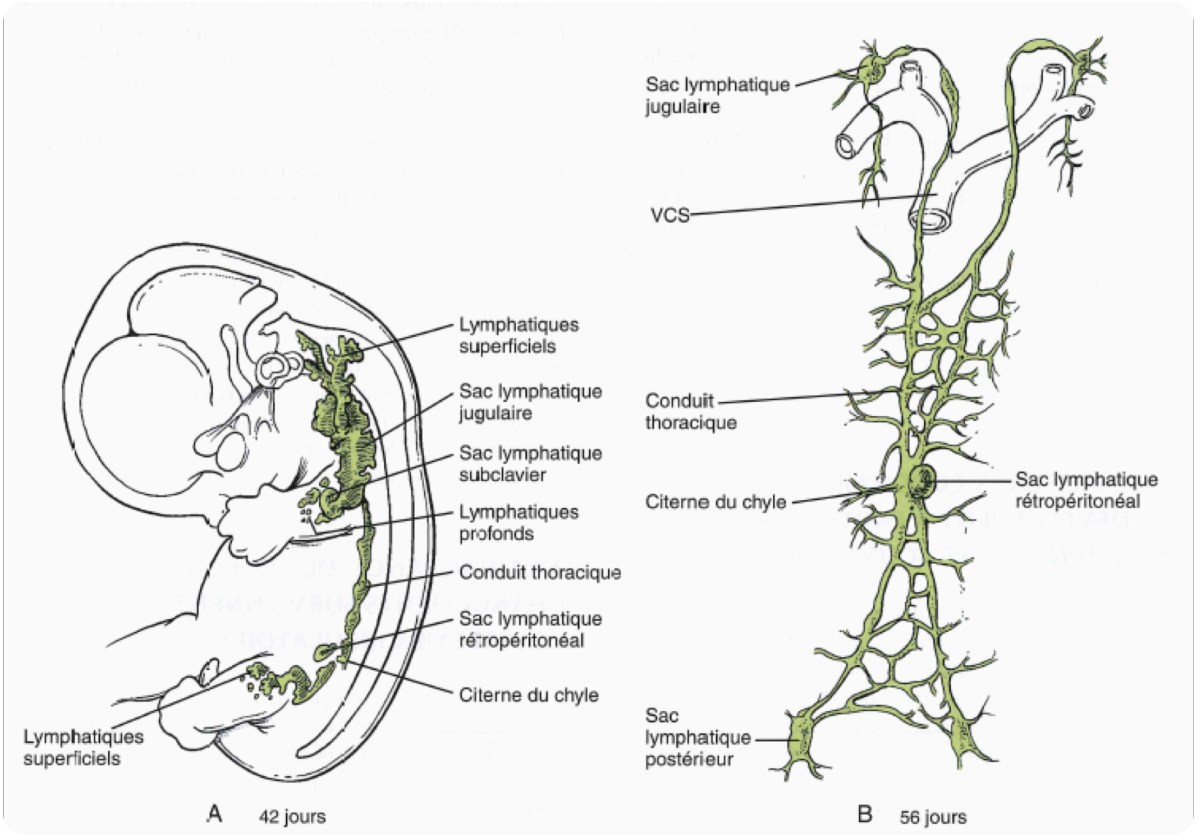


ABB. — Entwicklung des Lymphsystems

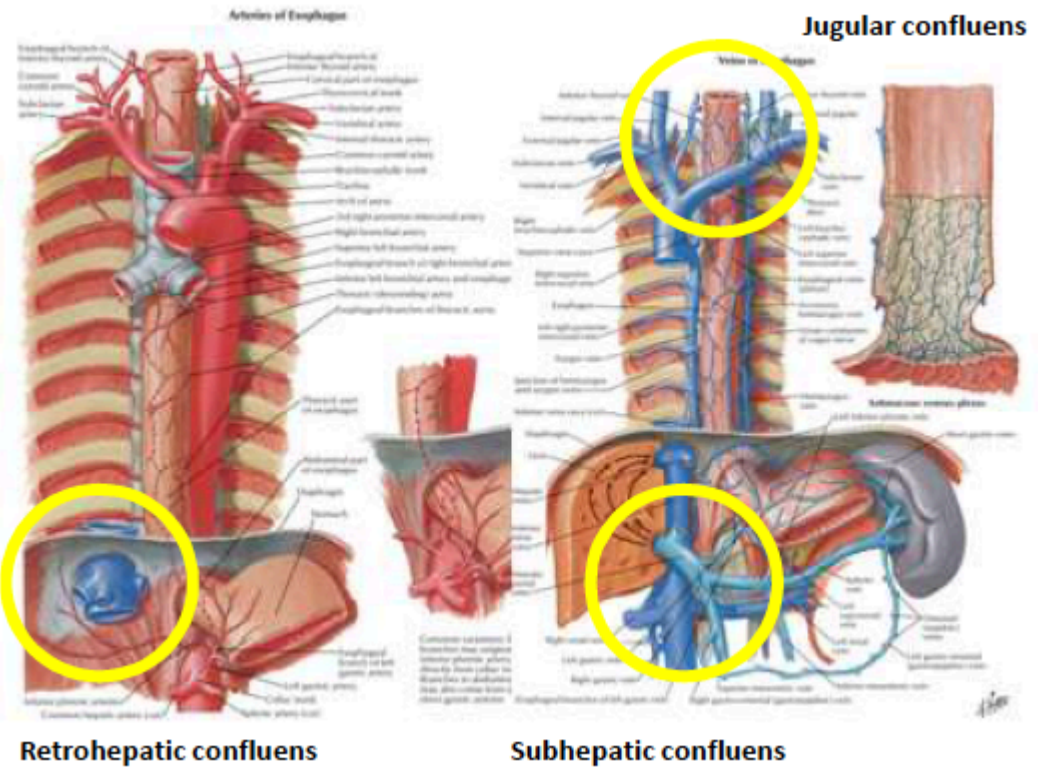


ABB. — Ösophagus-Seitenvenen

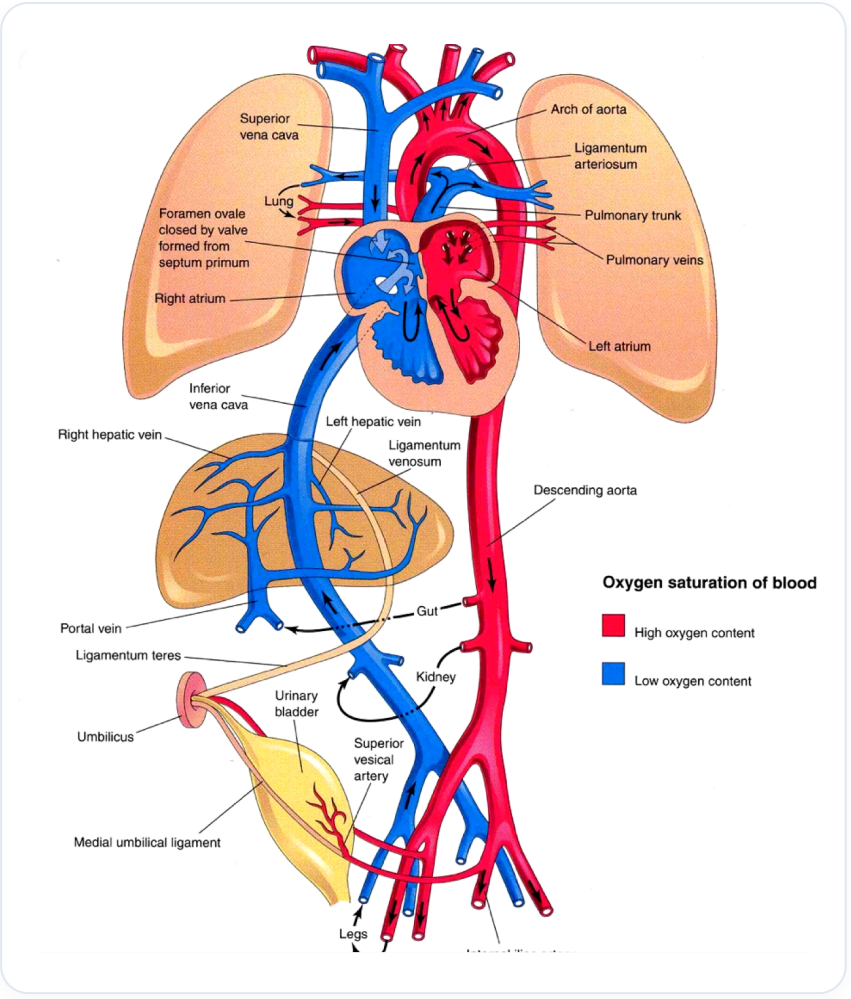


ABB. — Menschlicher fetaler Kreislauf